核心精讲·呼吸系统肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发性支气管肺癌（肺癌）肺癌

- 起源于支气管粘膜（大部分）
- 起源于肺泡

（一）病因举例

①**吸烟**：最常见。吸烟与所有病理类型肺癌的危险性相关 (1)
腺癌有EGFR基因突变，可针对基因突变进行靶向治疗，而吸烟会影响基因突变以及靶向治疗的疗效
②空气污染：肺癌发病率城市高于农村；厨房做饭油烟（对女性腺癌影响大）

③结核（主要为腺癌）
导致免疫力下降

（二）病理变化

1.大体类型

①**中央型/肺门型（最常见）**起源于大支气管粘膜，靠近中央/肺门

②**周围型：常侵犯胸膜**

③弥漫型：起源于末梢肺组织，易与转移癌混淆





图 10-20　肺癌(中央型)
近肺门部癌组织包绕管壁增厚的支气管。



图 10-21　肺癌(周围型)

2.组织学类型 (2)
大体类型(肉眼见)-总分
组织学类型(显微镜下观)-单科　不要把大体类型和组织学类型混淆
还有其他类型的肺癌，如鳞癌小细胞肺癌，中央型多见(总分第一)
而腺癌是跟这些类型肺癌相比多见(单科第一)

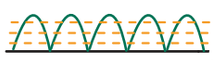
（1）**腺癌**

①**女性肺癌最常见**，多为**非**吸烟者
厨房油烟

②多为**周围型**

③**特殊腺癌**周边县城泡菜 nb

癌组织累及腺上皮C但没有突破基底膜(原位癌)



细支气管肺泡癌（原位腺癌）	多为弥漫型，呈**肺炎样外观**
黏液癌	可呈胶冻状
瘢痕癌 (3)	

(1) 理顺知识点：
吸烟与所有类型的肺癌都相关。
吸烟是最常见的危险因素，但是腺癌是目前最常见的肺癌组织学类型，腺癌又多见于非吸烟的女性。这两者是不矛盾的。

肺腺癌的患者常常有EGFR基因的突变，于病理学中不必完全掌握，于内科学中仔细学习。可以运用药物(厄洛替尼、吉非替尼)针对EGFR基因的靶点进行治疗。但是吸烟会影响到EGFR的基因突变，进而影响到靶向治疗的疗效。因此，吸烟对女性肺癌患者同样都有影响。
所以，吸烟是最常见的危险因素，对所有病例类型的肺癌都相关。

(2) 理顺知识点：
最新观点认为腺癌是肺癌中最常见的组织学类型，而肺癌的大体分型中，中央型是最多见的。

在肺癌的组织学分型中有腺癌、鳞癌等，其中腺癌是最常见的(单科第一)，而腺癌的大体分型多表现为周围型，其他的组织学类型，如鳞癌、小细胞肺癌、大细胞肺癌等大都表现为中央型，所以即使组织学类型中多见腺癌，但在大体分型中仍是中央型更多见(总分第一)。

(3) 需注意，此处的细支气管肺泡癌、黏液癌、瘢痕癌都是特殊腺癌，即鳞癌、小细胞肺癌等并不存在这些特殊类型，请注意各种不同分类的范围。

（2）鳞癌　高分化:接近正常组织,异型性小,恶性程度低
低分化:与正常组织差异大,异型性大,恶性程度高

①多为男性、吸烟者、**中央**型

②来源于支气管上皮**鳞化**，包括：

高分化/角化型	癌巢有**角化珠、细胞间桥**高龄华侨　鳞状上皮特点:角化
低分化/非角化型	
基底细胞样型	癌细胞小、胞质少、栅栏状排列 ④

（3）**神经内分泌癌（APUD）**神经内分泌=APUD　=嗜银细胞

①包括：**小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、类癌**（**类癌恶性度最低**类似癌）小大类

②起源于支气管黏膜上皮的**嗜银细胞**/Kulchitsky

③小细胞癌人小鬼大还贪财、裸露菊花

多为**男**性、**吸烟**者、**中央**型　⑤ 生长速度快的肿瘤细胞一般对放疗敏感
恶性度最高、分化最低、最早最易转移、对放化疗最敏感、预后最差（①早期转移 ②容易耐药）
燕麦细胞：癌细胞小、胞质少似 ttsx **裸核** 胞质少凸显细胞核
可围绕小血管形成**假菊形团**结构
异位分泌抗利尿激素、ACTH、5-HT 等类癌综合征

顽固性低钠血症　库欣综合征

小细胞癌分泌ADH作用于集合管基底膜V2-R导致顶端膜AQP-2↑→水重吸收↑→稀释钠离子(稀释性低钠血症)/顽固性低钠血症(怎么补钠都不好转)→查胸部CT(看肺有无肿块)

⑥

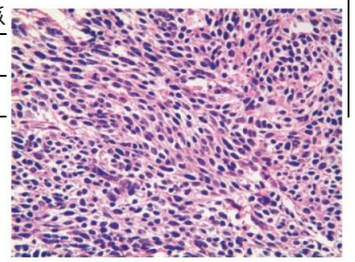


图 10-23　肺小细胞癌(燕麦细胞癌)
癌细胞小、梭形,胞质少,似裸核,平行排列呈片状。

（4）大细胞未分化癌

（5）腺鳞癌：癌组织有腺癌和鳞癌（两种成分各占 10%以上、不管何种组织结构为主）

3.转移

①晚期淋巴转移最多见于：**右**锁骨上淋巴结 *VS* 食管癌、胃癌晚期淋巴转移最多见于:左锁骨上淋巴结

②肺癌血道转移最多见于：**脑、肾上腺、骨**

（三）隐性肺癌

①肺内无明显肿块、**无淋巴结转移**、影像学检查**(-)**

②痰细胞学检查癌细胞**(+)**
- 特异性高:只要阳性就可以诊断
- 敏感性低:不容易查到阳性

③手术切除标本经病理证实为支气管黏膜**原位癌或早期浸润癌**

④ 理顺知识点:
注意此处的文字描述,“基底细胞样”型,指的是此时的肿瘤细胞和基底细胞形态类似,并非是指这种肺癌是基底细胞癌变导致的。

支气管黏膜的基底膜存在一些基底干细胞。基底细胞体积小、胞质少,呈栅栏状排列。
类似的还有纤维素坏死和纤维素样坏死,都是不同的概念。

⑤ 理顺知识点:
小细胞肺癌对放化疗敏感的机制是:小细胞肺癌生长迅速,细胞中染色质不断复制,细胞不断分裂,因此小细胞肺癌对放化疗敏感。

但小细胞肺癌极易耐药,即虽然敏感,但治疗效果较差。同时小细胞肺癌早期易发生转移,发现并治疗时常常已发生转移,甚至于全身转移。
这两个方面都导致了小细胞肺癌的预后最差

⑥ 理顺知识点:
小细胞肺癌细胞可产生ACTH、ADH、5-HT等内分泌物质。
ACTH导致糖皮质激素增多,出现库欣综合征;5-HT导致类癌综合征(指肿瘤分泌的血管活性物质导致皮肤潮红、腹泻、喘息等兴奋表现);ADH可导致水重吸收增加,导致水潴留,出现顽固性/稀释性低血钠。“小库拿来”

这些内分泌物质,在生理情况下应该由下丘脑产生,但现在由小细胞肺癌细胞产生,而小细胞肺癌在肺内,因此被称为异位内分泌综合征。



（四）早期肺癌（无淋巴结转移）

早期食管癌、胃癌:无论有无淋巴转移

①中央型：位于大支气管，癌组织仅限于管壁内生长（未侵犯肺实质）。包括腔内型和管壁浸润型

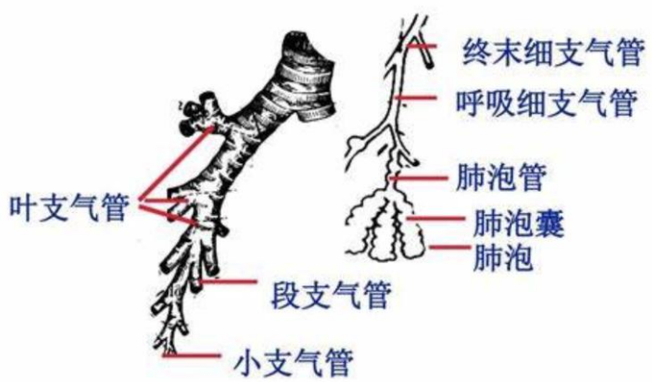
②周围型：在肺组织内呈结节状，直径＜2cm

直径越大越偏向于后期

《病理学》10 版教材 P190：中央型肺癌发生于主、叶支气管（教材定义错误×）

正确的定义为中央型肺癌发生于段及以上支气管（主、叶、段支气管，即大支气管）

⑦



⑦ 理顺知识点：

气管传导区包括主、叶、段、小、细、终末细支气管，其中终末细支气管为传导区最后，在传导区之前无肺泡开口，只起传导气体作用，即解剖无效腔。　“主页短小西综”

中央型肺癌是指发生在段及其以上的支气管，即主、叶、段支气管，而发生在段以下支气管发生了肺癌为周围型肺癌。

若段及其以上的支气管内发生了癌变，并且肿瘤只在管壁内生长，则称为早期的中央型肺癌。

若肿瘤位于段以下支气管，且肿瘤形成的结节直径＜2cm，则称为早期的周围型肺癌。

需注意，早期肺癌一定没有淋巴结的转移，而早期食管癌/胃癌则只讨论浸润深度，无论有无局部淋巴结转移。

二、鼻咽癌

1.与 **EBV** 密切相关

（**与 EBV 密切相关的有：鼻咽癌**的分化性鳞癌、**霍奇金淋巴瘤**（CHL）的经典型、**Burkitt 淋巴瘤**、**NK/T 细胞淋巴瘤**）比伯穿 CK

非肿瘤:传染性单核细胞增多症　比伯单穿CK

2.鼻咽顶部最多见，大体类型以结节型最多见，组织学类型以分化性**鳞癌**最多见

①高分化/角化型：癌巢内细胞分层明显、角化珠、细胞间桥

②低分化/非角化型

3.**放疗**为主：恶性程度高的低分化鳞癌和泡状核细胞癌对放疗敏感低龄放炮

真题解析·呼吸系统肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N51 A 细支气管肺泡癌属于以下哪种肿瘤类型
周边县城泡菜nb
A.腺癌
B.小细胞癌
C.大细胞癌
D.鳞状细胞癌

2. 2015N168 X 呼吸系统肿瘤中，由神经内分泌细胞发生的有
神经内分泌=APUD=嗜银细胞
小大类
A.支气管类癌
B.小细胞癌
C.鳞癌
D.腺癌

3. 2020N36 A 与 EB 病毒感染密切相关的肿瘤是
比伯穿CK
A.鼻咽癌
B.胃腺癌 幽门螺杆菌
C.宫颈鳞癌 HPV
D.肺鳞癌 吸烟

4. 2023N32 A 男性，62 岁。体检时发现右锁骨上淋巴结肿大，无压痛。淋巴结切除送检，病理诊断：淋巴结内可见腺癌浸润。肿瘤原发部位最可能是
无痛性肿大优先考虑肿瘤
偏向恶性
A.食管
B.胃
C.肝
D.肺

5. 2025N35 A 男性，70 岁。体检发现左肺门处直径约 3cm 大小的不规则肿物。支气管镜活检组织的病理学特点：肿瘤细胞呈片状、条索状排列，呈浸润性生长；肿瘤细胞体积小，胞质少，似裸核，异型性明显，核分裂象多。该肿瘤最可能的病理类型是
人小鬼大还贪财,裸露菊花
A.浸润性腺癌
B.鳞状细胞癌
C.小细胞癌
D.腺鳞癌

思维导图 • 呼吸系统肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-5 A AB A D C